



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نادية على مصطفى عابدين

العنوان : ..

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : المعصره

رقم البطاقة : 26108282101185 رقم التليفون : 01098666017 تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 28-08-1961 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) قسم العلاج : الاورام [14152]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نادية علي مصطفى عابدين National ID: 26108282101185	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Docetaxel chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جوستاف روستاف
مستشفى
9-20

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

09/20/2026

MDT FORM

Name: نادية على مصطفى عابدين	MRN: 12627
Age: 65 Y	ID: 26108282101185
Menopausal Sta: post	Phone:* 01098666017
NRS SCORE:	Marital Status: married
BMI:	Family History: -ve
Gender:	Reason Of MDT: NEW
CO Morbidity: DM	ECOG Performance Status: 0 0 1 2 3 4
Surgical History:* cholecystectomy	

Clinical Data:

BX: RT IDC 2

ER: 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** amplified **KI67:** 15%

History:**Sonomammography:**

CESM RT multiple UOQ enhancing masses + PLN

Biomarker/Molecular

Luminal B2

Mets Workup:

ct cap free

bone scan free

Recommendations:**MDT Outcome & Plan**

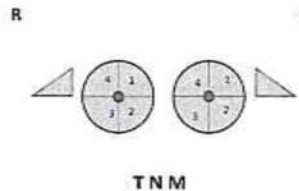
PORTA-CTH

ECHO

NA TCHPX6

MULTIFOCAL BUT LARGE BREAST FOR CLIPPING

RT WLE+ALND



Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

T3 m N1 M0 + nipple retraction

Pathological Staging:**SIGNATURE**

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. محمد كيلاسي	د. محمد خير اوي		

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

ناديه
على مصطفى عابدين
١٢ ش عبید الشرقاوى - المعصرة المحطة
المعصرة - القاهرة

١٩٦١/٠٨/١٨ ٢٦١٠٨٢٨٢١٠١١٨٥

١04435358



Patient Name	ناديه على مصطفى	Case No.	339300
Sex/Age	Female 64 Y	Patient No.	24301
Registered Date	29/6/2026 03:27:31 PM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	20/7/2026 02:01:41 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	25/7/2026 09:19:16 AM	Pathology No.	2061/26

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 4c).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 29/06/2026, at 1:36 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), Ki67 clone (30-9) & SISH.

Microscopic examination:

- **Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
- **Histologic grade:** 2 (Differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- **Ductal carcinoma in situ:** Absent.
- **Angioinvasion:** Present.
- **Perineural invasion:** Absent
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Mild.
- **Necrosis:** Focal.

Results:

* **IPT (All controls showed appropriate reactivity):**

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 40% of tumor cells (score 6/8).



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	ناديه على مصطفى	Case No.	339300
Sex/Age	Female 64 Y	Patient No.	24301
Registered Date	29/6/2026 03:27:31 PM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	20/7/2026 02:01:41 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	25/7/2026 09:19:16 AM	Pathology No.	2061/26

- Her2: Intermediate complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- SISH: Amplified. (Average Her2 copy No.: (4.95), Her2/CEP17 ratio: (2.1)).
- Ki67%: 15%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Amplified, Group I. (Average Her2 copy No.: (4.95), Her2/CEP17 ratio: (2.1)).
- Ki67%: 15%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	ناديه على مصطفى	Case No.	339300
Sex/Age	Female 64 Y	Patient No.	24301
Registered Date	29/6/2026 03:27:31 PM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	20/7/2026 02:01:41 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	25/7/2026 09:19:16 AM	Pathology No.	2061/26

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

ISH groups:

The ratio is calculated and the results is interpreted as:

- Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
- Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
- Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
- Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result).
- Group V (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient's Name: Nadia Ali Mustafa
Date: 2026-06-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 64-year-old female with right breast palpable lump

Findings:

right breast.

- Dense fibroglandular densities. (ACR c) may obscuring small lesion
- center of outer third shows two ill defined high density mass lesions with groups of pleomorphic calcifications seen in between lesion
- **Ultrasound** demonstrated between 8-9 clock along duct shows multiple irregular heterogeneous hypo echoic solid mass lesions
 - index lesion at 8 o'clock, zone c 10cm from nipple, 11 mm deep to the skin measuring 20x23mm
 - inner to index lesion at 8 o'clock, way from it by 8mm 9cm from nipple, 16 mm deep to the skin measuring 16x12mm
 - at 9 o'clock, zone b 3cm from nipple, 12mm deep to the skin measuring 25x15mm
 - para areolar at 9 o'clock, 1.5 cm from nipple, 10 mm deep to the skin measuring 21x13mm
 - with prominent ducts in between lesions and reaching to nipple causing nipple retractions
 - two lymph node are seen at level I. largest measuring 18x8mm with focal cortical thickening 5mm and smallest measures 11x7mm and focal cortical thickening 3mm ??indeterminate

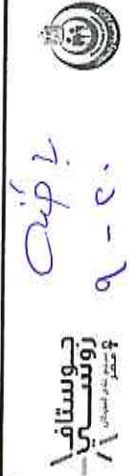
left breast.

- Dense fibroglandular densities. (ACR c)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

- right breast (BIRADS 4c): multiple Malignant looking lesions for biopsy and CESM
- left breast (BIRADS 1): Normal study.

Best Regards,
DR. Marwa M.Hassan



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية



09/20/2026

MDT FORM

Name:	تقي علي مصطفى عاين	MRN:	12627
Age:	65 Y	ID:	26108282101185
Menopausal Sta	post	Phone:*	01098666017
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	-ve
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	DM	NEW	
Surgical History:*	cholecystectomy	ECOG Performance Status	0 0 1 2 3 4

Clinical Data:

BX: RT IDC 2

ER: 8/8 PR: 6/8 HER2: amplified KI67: 15%

History:

Sonomammography:
CESM RT multiple UOQ enhancing masses + PLN

Biomarker/Molecular
Luminal B2

Mets Workup:
ct cap free
bone scan free

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

PORTA-CTH
ECHO
NA TCHPX6
MULTIFOCAL BUT LARGE BREAST FOR CLIPPING
RT WLE+ALND

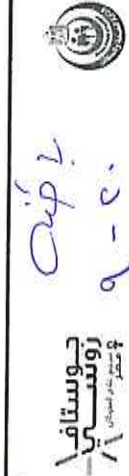
Clinical Staging:

T3 m N1 M0 + nipple retraction

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. محمد كبرلي	د. محمد تارابي		



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية



09/20/2026

MDT FORM

Name:	تقي علي مصطفى عايد	MRN:	12627
Age:	65 Y	ID:	26108282101185
Menopausal Sta	post	Phone:*	01098666017
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	-ve
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	DM	NEW	
Surgical History:*	cholecystectomy	ECOG Performance Status	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Clinical Data:

BX: RT IDC 2

ER: 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** amplified **KI67:** 15%

History:

Sonomammography:
CESM RT multiple UOQ enhancing masses + PLN

Biomarker/Molecular
Luminal B2

Mets Workup:

ct cap free
bone scan free

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

PORTA-CTH
ECHO
NA TCHPX6
MULTIFOCAL BUT LARGE BREAST FOR CLIPPING
RT WLE+ALND

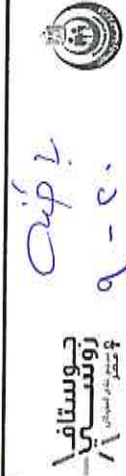
Clinical Staging:

T3 m N1 M0 + nipple retraction

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د محمد كبراني	د محمد تاراري		



مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية



09/20/2026

MDT FORM

Name:	تقي علي مصطفى عاين	MRN:	12627
Age:	65 Y	ID:	26108282101185
Menopausal Sta	post	Phone:*	01098666017
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	-ve
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	DM	NEW	
Surgical History:*	cholecystectomy	ECOG Performance Status	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Clinical Data:

BX: RT IDC 2

ER: 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** amplified **KI67:** 15%

History:

Sonomammography:
CESM RT multiple UOQ enhancing masses + PLN

Biomarker/Molecular
Luminal B2

Mets Workup:
ct cap free
bone scan free

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

PORTA-CTH
ECHO
NA TCHPX6
MULTIFOCAL BUT LARGE BREAST FOR CLIPPING
RT WLE+ALND

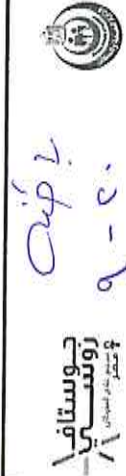
Clinical Staging:

T3 m N1 M0 + nipple retraction

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د محمد كبراني	د محمد تاراري		



مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية



09/20/2026

MDT FORM

Name:	تقي علي مصطفى عاين	MRN:	12627
Age:	65 Y	ID:	26108282101185
Menopausal Sta	post	Phone:*	01098666017
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	-ve
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	DM	NEW	
Surgical History:*	cholecystectomy	ECOG Performance Status	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Clinical Data:

BX: RT IDC 2

ER: 8/8 **PR:** 6/8 **HER2:** amplified **KI67:** 15%

History:

Sonomammography:
CESM RT multiple UOQ enhancing masses + PLN

Biomarker/Molecular
Luminal B2

Mets Workup:

ct cap free
bone scan free

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

PORTA-CTH
ECHO
NA TCHPX6
MULTIFOCAL BUT LARGE BREAST FOR CLIPPING
RT WLE+ALND

Clinical Staging:

T3 m N1 M0 + nipple retraction

Pathological Staging:

T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. محمد كبراني	د. محمد تاراي		